3 Soziale Integration und soziale Unterstützung

Lernziele

Nach der Lektüre dieses Kapitels

- können Sie den Unterschied zwischen sozialer Integration und sozialer Unterstützung erläutern,
- können Sie verschiedene Funktionen und Formen von sowie Perspektiven auf soziale Unterstützung unterscheiden,
- können Sie die Wirkung sozialer Integration versus Isolation und sozialer Unterstützung auf das psychische Wohlbefinden und die physische Gesundheit beschreiben,
- können Sie verschiedene Wirkmechanismen von sozialer Integration versus Isolation und sozialer Unterstützung auf das psychische Wohlbefinden und die physische Gesundheit darlegen,
- kennen Sie die wichtigsten Determinanten für soziale Integration sowie den Erhalt beziehungsweise die Bereitstellung von sozialer Unterstützung.

3.1 Begriffsbestimmung

Die Begriffe soziale Integration und soziale Unterstützung beziehen sich auf unterschiedliche Aspekte interpersonaler Beziehungen und werden zunächst voneinander abgegrenzt.

3.1.1 Soziale Integration versus Isolation

Mit sozialer Integration ist die Einbettung in ein soziales Netzwerk gemeint. Soziale Netzwerke formen sich aus den direkten und indirekten sozialen Beziehungen einer Person zu anderen Personen, wie Familie, Freund:innen, Bekannten, Nachbar:innen oder Kolleg:innen (vgl. Wrzus et al., 2013). Bei sozialer Integration stehen die *quantitativen und strukturellen Merkmale von sozialen Beziehungen* im Mittelpunkt. Indikatoren zur Bestimmung der sozialen Integration versus Isolation sind beispielsweise der Familienstand, die Zahl der Verwandten, Freund:innen und Bekannten sowie die Häufigkeit des Kontakts mit anderen Personen. Andere Parameter zur Charakterisierung sozialer Netzwerke sind Dichte (Ausmaß der tatsächlich vorhandenen Beziehungen einer Person im Vergleich zu den theoretisch möglichen Kontakten im Netzwerk), Dauer (Länge der bestehenden Beziehungen) und Reziprozität (Gegenseitigkeit der sozialen Beziehung).

Nach Laireiter (1993)lassen sich vier Dimensionen sozialer Netzwerke unterscheiden:

1. Die *Struktur von Netzwerken* ist gekennzeichnet durch die Anzahl und Vernetzung der Bindungen.
2. Die *Beziehungen zu den Netzwerkmitgliedern* kann durch die Dauer, Art und Häufigkeit der Kontakte beschrieben werden.
3. Hinsichtlich des *Inhaltes der Beziehungen* können unterstützende von belastenden Beziehungen unterschieden werden.
4. Letztlich nehmen die Netzwerkteilnehmenden eine *Evaluation ihrer Beziehungen* vor.

Soziale Integration stellt eine wichtige Voraussetzung für soziale Unterstützung dar, denn wer niemanden kennt, wird geringe Chancen haben, Hilfe bei der Bewältigung von Belastungen zu erhalten (Schwarzer, 2004).

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

3.1.2 Soziale Unterstützung

Soziale Unterstützung bezieht sich auf *qualitative und funktionale Aspekte von sozialen Beziehungen*. Sie umfasst die „Interaktion zwischen zwei oder mehr Menschen, bei der es darum geht, einen Problemzustand, der bei einem Betroffenen Leid erzeugt, zu verändern oder zumindest das Ertragen dieses Zustandes zu erleichtern, wenn sich objektiv nichts verändern lässt" (Schwarzer, 2004, S. 177). Soziale Unterstützung beinhaltet also, dass Personen Hilfestellungen erhalten beziehungsweise angeboten bekommen, um Aufgaben und Belastungen zu bewältigen sowie persönliche Ziele zu erreichen.

Formen sozialer Unterstützung

Der Umsetzung des Unterstützungszieles, nämlich den Problemzustand zu beseitigen oder das subjektive Wohlbefinden zu steigern, können verschiedene Unterstützungshandlungen dienen. So könnten emotionale Befindlichkeiten des Unterstützungsempfängers beeinflusst, konkrete Hilfeleistungen erbracht oder Informationen zur Bewältigung der Situation zur Verfügung gestellt werden. Demnach lassen sich drei verschiedene Formen sozialer Unterstützung unterscheiden (vgl. Helgeson, 2003). *Emotionale Unterstützung* beinhaltet die Vermittlung von Trost, Wärme und Zuspruch sowie den Ausdruck von Sorge und Zuneigung. *Instrumentelle Unterstützung* umfasst konkrete Hilfeleistungen bei zu erledigenden Aufgaben, die Bereitstellung finanzieller Mittel oder die Besorgung benötigter Waren. *Informationelle Unterstützung* bezieht sich auf die Übermittlung relevanter Informationen sowie das Erteilen von Ratschlägen oder Hinweisen.

Wahrgenommene versus erhaltene Unterstützung

Es können kognitive und verhaltensbezogene (behaviorale) Aspekte sozialer Unterstützung unterschieden werden (vgl. Dunkel-Schetter & Bennett, 1990). Der *kognitive Aspekt* bezieht sich auf antizipierte oder wahrgenommene Unterstützung (engl.: perceived support). Diese beschreibt das Ausmaß, in dem eine Person erwartet und überzeugt ist, bei Bedarf soziale Unterstützung aus ihrem sozialen Netzwerk zu erhalten. Diese prospektive Einschätzung, im Bedarfsfall über soziale Unterstützung zu verfügen, ist verschiedenen Untersuchungen zufolge relativ unabhängig vom realen Unterstützungsverhalten des sozialen Umfeldes und wird daher von einigen Autor:innen als ein stabiles Persönlichkeitsmerkmal angesehen (z. B. Sarason et al., 1990). Der *verhaltensbezogene Aspekt* bezieht sich auf konkretes Unterstützungsverhalten beziehungsweise tatsächlich erhaltene Unterstützung (engl.: received support). Hierbei geht es darum, wie oft und wie wirksam hilfreiche Handlungen in erlebten stresshaften Situationen ausgeführt wurden. Diese Perspektive ist also retrospektiv und zielt auf tatsächliche Unterstützungsleistungen.

Perspektiven auf soziale Unterstützung

Tatsächliche Unterstützungsprozesse können aus drei verschiedenen Perspektiven[2] betrachtet werden, nämlich der des Empfängers, des Gebers und des Beobachters (vgl. Dunkel-Schetter et al., 1992; siehe auch Abbildung 3.1). Die Sichtweisen des Empfängers und des Gebers spiegeln dabei die erhaltene beziehungsweise die gegebene Unterstützung in bereits stattgefundenen Unterstützungsinteraktionen wider. Die Übereinstimmung zwischen Empfänger und Geber innerhalb von Unterstützungsdyaden liegt verschiedenen Untersuchungen zufolge mit 8 bis 30 % und seltenen Fällen 61 % jedoch lediglich im niedrigen bis mittleren Bereich (z. B. Knoll et al.,

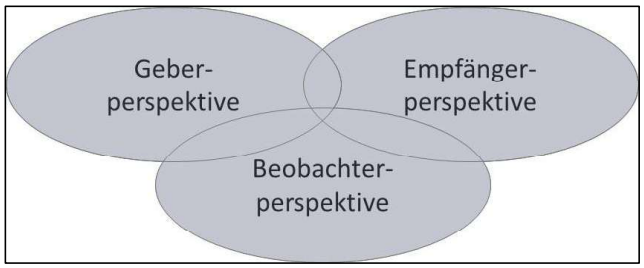
[2] Da es sich bezüglich der Perspektiven bei „Geber", „Empfänger", „Beobachter" um lange etablierte Begriffe handelt, wird in diesem gesamten Kapitel darauf verzichtet, genderkonforme, aber ungebräuchliche Begriffe zu verwenden.

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

2006). Ein möglicher Grund für die geringe Übereinstimmung dieser beiden Perspektiven ist, dass es auf beiden Seiten zu unterschiedlichen Interpretationen von Verhalten kommen kann, indem entweder ein als unterstützend intendiertes Verhalten des Gebers vom Empfänger nicht als Unterstützung wahrgenommen wird oder ein vom Empfänger als unterstützend wahrgenommenes Verhalten vom Geber nicht als Unterstützung intendiert war. Nachdem die Forschung zu sozialer Unterstützung lange Zeit fast ausschließlich die Perspektive des Empfängers berücksichtigt hat, werden in neueren Untersuchungen zunehmend beide Perspektiven betrachtet, um Unterstützungsprozesse umfassend abzubilden (z. B. Lüscher et al., 2015; Vollmann et al., 2011). Letztlich können soziale Interaktionen, die einen Austausch von sozialen Unterstützungsleistungen beinhalten, auch aus einer dritten Perspektive, der Beobachterperspektive einer unbeteiligten Person, beschrieben und bewertet werden (Girme et al., 2013; Kulik & Mahler, 1989). Die Einschätzungen eines Beobachters von Unterstützungsinteraktionen können wiederum aufgrund eigener Interpretationen von den anderen zwei Perspektiven abweichen.

Abbildung 3.1

Verschiedene Perspektiven auf soziale Unterstützung. Nach Dunkel-Schetter et al., 1992, S. 86



3.2 Effekte sozialer Integration und sozialer Unterstützung auf psychisches Wohlbefinden und physische Gesundheit

Soziale Beziehungen spielen eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung und Förderung psychischen Wohlbefindens und physischer Gesundheit (Holt-Lunstad et al., 2010; siehe auch Video 3.1).

Video 3.1. The hidden influence of social networks (Nicholas Christakis). Verfügbar unter https://www.ted.com/talks/nicholas_christakis_the_hidden_influence_of_social_networks

3.2.1 Soziale Integration und psychisches Wohlbefinden sowie physische Gesundheit

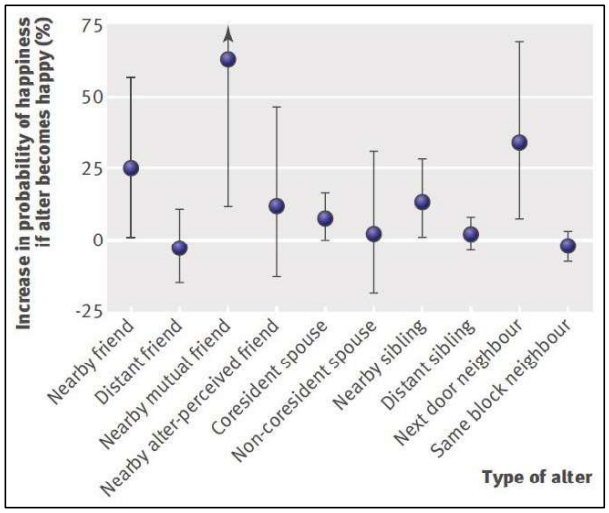
In verschiedenen Längsschnittstudien zeigte sich, dass die Größe des sozialen Netzwerkes und die Kontakthäufigkeit mit Personen des sozialen Netzwerkes positive Prädiktoren von Lebenszufriedenheit, Lebensqualität und mentaler Gesundheit sind (z. B. Rafnsson et al., 2015). Weiterhin wurde gefunden, dass emotionale Zustände kollektive Phänomene sind, die sich in sozialen Netzwerken verbreiten. Beispielsweise berichten Fowler und Christakis (2008) basierend auf längsschnittlichen Daten über einen Zeitraum von 20 Jahren, dass Personen im Zentrum eines sozialen Netzwerkes glücklicher sind als Personen am Rande des Netzwerkes. Glückliche Menschen bilden laut dieser Studie Cluster, das heißt, sie sind überzufällig häufig miteinander verbunden. Weiterhin steigt die Wahrscheinlichkeit, selbst glücklich zu werden, mit der Anzahl glücklicher Personen im sozialen Netzwerk. In Bezug auf die Verbreitung von Glück legen die Befunde nahe, dass vor allem emotionale und geografische Nähe relevant sind. So steigt die Wahrscheinlichkeit, selbst glücklich zu werden um 25 %, wenn ein:e Freund:in, der/die maximal

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

eine Meile entfernt wohnt, in der letzten Zeit glücklich geworden ist. Freund:innen, die mehr als eine Meile entfernt wohnen, haben keinen solchen Effekt (siehe Abbildung 3.2). Ähnliches wurde auch für Depression gefunden. Personen mit einem großen sozialen Netzwerk und im Zentrum des sozialen Netzwerkes erfahren weniger depressive Symptome. Bezüglich der Verbreitung von Depression zeigte sich, dass die Wahrscheinlichkeit eine Depression zu entwickeln um 93 % steigt, wenn eine Person des direkten Umfelds eine Depression hat. Dieser Übertragungseffekt besteht auch dann noch, wenn die Verbindung zu depressiven Personen nur indirekt ist. Hat beispielsweise der/die Freund:in eines/r Freund:in eine Depression, ist die Wahrscheinlichkeit, selbst eine Depression zu entwickeln, noch immer um 45 % erhöht (Rosenquist et al., 2011).

Abbildung 3.2

Wahrscheinlichkeit der Zunahme von Glück, nachdem jemand anderes im sozialen Netzwerk glücklich wurde. Aus Fowler und Christakis, 2008, S. 6



Die Zugehörigkeit zu einem sozialen Netzwerk hat jedoch nicht nur Effekte auf das psychische Wohlbefinden, sondern auch auf Indikatoren physischer Gesundheit. So zeigte sich beispielsweise in Studien von Holt-Lundstad und Kolleg:innen, dass glücklich verheiratete Personen niedrigere Blutdruckwerte haben als Singles (und auch als nicht glücklich verheiratete Personen) und dass verheiratete Paare mit Kindern (und hier vor allem Frauen) niedrigere Blutdruckwerte haben als verheiratete kinderlose Paare (Holt-Lunstad et al., 2009; Holt-Lunstad et al., 2008). Zudem erwiesen sich in Meta-Analysen soziale Isolation und Alleinleben als Risikofaktoren sowie ein großes soziales Netzwerk und Verheiratetsein als protektive Faktoren für die allgemeine Mortalität und die Mortalität in Bezug auf eine Krebserkrankung (Holt-Lunstad et al., 2015; Holt-Lunstad et al., 2010; Pinquart & Duberstein, 2010). Im Kontext der COVID-19 Pandemie zeigte sich außerdem, dass eine glückliche Beziehung, bei der das Paar zusammenlebt, einen Schutzfaktor gegen Einsamkeit und einen Puffer gegen physiologische Stressreaktionen darstellte(Hopf et al., 2022). Soziale Integration geht zudem mit Indikatoren eines günstigeren Krankheitsverlaufs einher, wie zum Beispiel eine schnellere Entlassung aus dem Krankenhaus, das Überleben eines Herzinfarkts oder ein geringes Risiko für das Wiederauftreten einer Krebserkrankung (z. B. Cohen, 2004; Kulik & Mahler, 1989; siehe auch Kasten 3.1). Auch im Hinblick auf die psychische Gesundheit lässt sich als Folge einer Scheidung – unabhängig von Alter und Geschlecht – eine geringere Lebenszufriedenheit, vermehrte depressive Symptome und zunehmende Einsamkeit im darauffolgenden Jahr verzeichnen (Wahring et al., 2025).

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

3.2.2 Soziale Unterstützung und psychisches Wohlbefinden sowie physische Gesundheit

Von den in Abschnitt 3.1.2 beschriebenen Arten sozialer Unterstützung scheint vor allem die *wahrgenommene Unterstützung* von Familienmitgliedern ein bedeutender Prädiktor für physische Gesundheit und psychisches Wohlbefinden zu sein (Cohen, 2004). In einer Meta-Analyse von Holt-Lunstad et al. (2010) zeigte sich beispielsweise, dass die Wahrnehmung im Bedarfsfall über soziale Unterstützung zu verfügen, prospektiv mit einem reduzierten Sterberisiko zusammenhängt, während dieser Effekt für den tatsächlichen Erhalt sozialer Unterstützung nicht aufgezeigt werden konnte. Shor et al. (2013) fanden zudem, dass die wahrgenommene Unterstützung von Familienmitgliedern einen stärkeren Effekt auf die Reduktion des Sterberisikos hat als die von Freund:innen oder anderen Personen aus dem sozialen Netzwerk. Im Kontext von Rehabilitation zeigte sich, dass die wahrgenommene Verfügbarkeit sozialer Unterstützung mit einer verbesserten körperlichen Gesundheit, aber auch einer höheren Lebensqualität sowie weniger Ängstlichkeit und Depressivität einhergeht(Chronister et al., 2008). Außerdem wurde in verschiedenen Studien eine protektive Wirkung von wahrgenommener sozialer Unterstützung hinsichtlich der Entstehung und des Verlaufes psychischer Störungen nachgewiesen (z. B. Gladstone et al., 2007; Wilcox, 2010).

In Bezug auf die Wirkung *tatsächlicher Unterstützungsprozesse* sind die Befunde weniger eindeutig (vgl. Nurullah, 2012). Einige Studien fanden, dass erhaltene Unterstützung keine Effekte auf die Sterblichkeit (Holt-Lunstad et al., 2010) oder gar negative Effekte auf das psychische Wohlbefinden (Bolger et al., 2000) hat. Für die negativen Effekte auf das psychische Wohlbefinden existieren zwei zentrale Erklärungsansätze. Zum einen wird argumentiert, dass konkrete, insbesondere informationelle und instrumentelle Unterstützungshandlungen vom Empfänger als aufdringlich, selbstwertbedrohlich und die Privatsphäre verletzend interpretiert werden könnten. Zum anderen wird diskutiert, dass es sich bei dem negativen Zusammenhang um ein Artefakt handelt, da konkrete Unterstützung vor allem Personen erhalten, die sich in belastenden Situationen befinden und deshalb ohnehin ein niedriges Wohlbefinden aufweisen (vgl. Nurullah, 2012). Andere Studien hingegen haben positive Effekte von erhaltener Unterstützung auf sowohl das psychische Wohlbefinden als auch die physische Gesundheit gefunden. In einer Meta-Analyse zeigte sich beispielsweise, dass im Kontext von Rehabilitation erhaltene soziale Unterstützung mit einer besseren Krankheitsanpassung und einer besseren psychischen Gesundheit einher geht (Chronister et al., 2008; siehe auch Kasten 3.1). Weiterhin wurde gefunden, dass erhaltene soziale Unterstützung einen protektiven Effekt bezüglich der Entstehung und einen positiven Effekt bezüglich des Verlaufs psychischer Störungen hat (Norman et al., 2005; Plaisier et al., 2007).

Kulik und Mahler publizierten 1989 eine der wenigen Studien, in denen das Ausmaß sozialer Integration und sozialer Unterstützung sowie deren Auswirkungen unter anderem mithilfe objektiver Kennwerte erfasst wurden. Sie untersuchten 52 verheiratete und 16 unverheiratete männliche Patienten vor und nach einer Bypass-Operation. Soziale Unterstützung wurde über die (durch das Klinikpersonal beobachtete) Anzahl der Besuche der Ehefrauen beziehungsweise anderer Personen operationalisiert. Als abhängige Variablen wurden zum einen die präoperative Angst über Fragebogen erhoben und zum anderen die Menge der postoperativen Schmerzmedikation, die Häufigkeit von physischer Aktivität und die Länge des Krankenhausaufenthalts aus den Akten übernommen.

Es zeigte sich, dass verheiratete Patienten seltener Schmerzmedikation benötigten und eine kürzere Verweildauer im Krankenhaus aufwiesen, wenn sie von ihren Ehepartnerinnen häufiger Besuch empfingen. Verheiratete Patienten mit viel sozialer Unterstützung wurden durchschnittlich

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

1.3 Tage eher aus dem Krankenhaus entlassen als verheiratete Patienten mit wenig sozialer Unterstützung. Unverheiratete Patienten erholten sich langsamer von der Operation als verheiratete Patienten mit viel Unterstützung, aber schneller als verheiratete Patienten mit wenig sozialer Unterstützung.

Kasten 3.1. Soziale Integration/Unterstützung und Rekonvaleszenz

Zusätzlich anzumerken sind im Kontext heterosexueller Beziehungen geschlechtsspezifische Unterschiede hinsichtlich der Auswirkungen auf die psychische und physische Gesundheit. Einige empirische Befunde legen nahe, dass Männer generell von Beziehungen gesundheitlich stärker profitieren als Frauen – zum Beispiel hinsichtlich der Aufnahme gesundheitsförderlicher, oder dem Reduzieren gesundheitsschädigender Verhaltensweisen(Wahring et al., 2024). Für Frauen hingegen hängt das Ausmaß gesundheitlicher Vorteile eng mit der Beziehungsqualität zusammen (Crockett & Neff, 2013; Ola & Mathur, 2016). Crockett und Neff (2013) untersuchten die geschlechtsspezifische Cortisolreaktion auf soziale Unterstützung innerhalb einer heterosexuellen Ehe und fanden heraus, dass die Ehemänner weniger von sozialer Unterstützung profitierten als ihre Frauen. Die Autorinnen vermuteten, dass das Angebot von Unterstützung als Folge männlicher Sozialisierungsprozesse als Angriff auf die eigene Selbstwirksamkeit interpretiert werden könnte. Ergänzend hierzu verweisen Wahring et al. (2024)darauf, dass Männer ein geringeres Ausmaß an emotionaler Unterstützung durch ihr sonstiges soziales Umfeld (z. B. durch Freundschaften, Familie) erhalten und daher mehr auf Beziehungen angewiesen sind, um dieses Bedürfnis zu erfüllen. Darüber hinaus weisen Männer einen stärker ausgeprägten Beziehungswunsch als Frauen auf, sind mit dem Singleleben weniger zufrieden und initiieren seltener eine Trennung (Wahring et al., 2025).

3.3 Effekte und Mechanismen der Wirkung sozialer Faktoren auf psychisches Wohlbefinden und physische Gesundheit

Im Folgenden werden die Effekte und Wirkmechanismen sozialer Faktoren auf das psychische Wohlbefinden und die körperliche Gesundheit näher betrachtet.

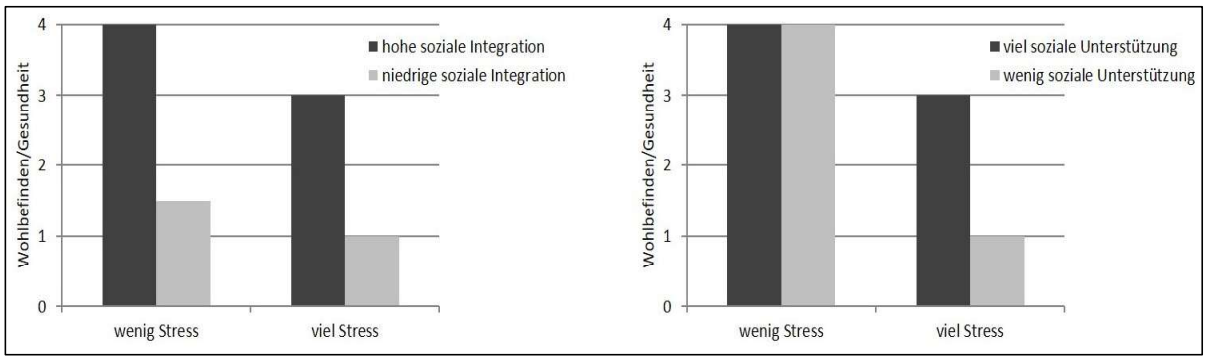
Haupteffekt vs. Puffereffekt

Im Hinblick auf die Beziehung zwischen sozialen Faktoren und Wohlbefinden beziehungsweise Gesundheit werden zwei verschiedene Modelle diskutiert (vgl. Cohen, 2004; Cohen & Wills, 1985). Im *Haupteffekt-Modell* wird angenommen, dass soziale Faktoren unabhängig von der Situation eine positive Wirkung auf das Wohlbefinden und die Gesundheit haben. Im *Puffereffekt-Modell* wird davon ausgegangen, dass die gesundheitsförderliche Wirkung der sozialen Faktoren nur in Zeiten hoher Stressbelastung zum Tragen kommt, indem sie die negativen Stressfolgen abmildern. Empirische Befunde legen nahe, dass soziale Integration sowie wahrgenommene Unterstützung als Haupteffekt auf die Gesundheit wirken, wohingegen erhaltene soziale Unterstützung einen Puffereffekt aufweist (siehe Abbildung 3.3).

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Abbildung 3.3

Schematische Darstellung des Haupteffekts von sozialer Integration (links) und des Puffereffekts von erhaltener Unterstützung (rechts)

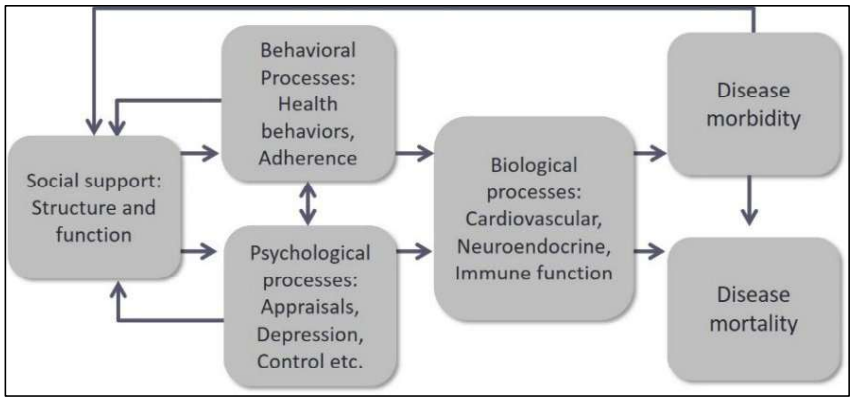


Wirkmechanismen

Es werden verschiede Mechanismen diskutiert, worüber soziale Faktoren auf die physische Gesundheit wirken (Uchino, 2006). Ein integratives Modell ist in Abbildung 3.4 dargestellt. Es wird postuliert, dass strukturelle und funktionale Aspekte sozialer Beziehungen, die Morbidität und Mortalität über zwei verschiedene, jedoch nicht unabhängige, Wirkungswege beeinflussen.

Abbildung 3.4

Wirkungswege von sozialer Unterstützung zu körperlicher Gesundheit. Aus Uchino, 2006, S. 378



Der erste Wirkungsweg beinhaltet *verhaltensbezogene Prozesse*, die mit sozialer Integration und Unterstützung im Zusammenhang stehen, wie beispielsweise ein besseres Gesundheitsverhalten (siehe auch Kurs 1, Kapitel 2 „Gesundheitsbezogenes Verhalten") und eine striktere Befolgung von ärztlichen Anweisungen. Dieser Effekt kann durch soziale Unterstützung in Form von Motivation und Information, aber auch durch das Gefühl, wichtig für andere Menschen zu sein, zustande kommen. Es konnte gezeigt werden, dass soziale Netzwerke einen Einfluss auf Gesundheitsverhaltensweisen, wie Alkoholkonsum und Rauchen, haben. Christakis und Fowler (2008) haben beispielsweise gefunden, dass die Wahrscheinlichkeit mit dem Rauchen aufzuhören zunimmt, wenn Ehepartner:innen und Freund:innen mit dem Rauchen aufhören. Ein eher negativer Netzwerkeffekt wurde ebenfalls gefunden, nämlich dass die Wahrscheinlichkeit übergewichtig zu werden ansteigt, sobald man mit einer übergewichtigen Person direkt oder indirekt verbunden ist (Christakis & Fowler, 2007; siehe Video 3.2). Es gibt empirische Belege, die dafür sprechen, dass Gesundheitsverhalten den Zusammenhang zwischen sozialen Faktoren und Mortalität zumindest teilweise vermittelt.

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Video 3.2. Spread of obesity (Christakis & Fowler). Verfügbar unter https://youtu.be/pJfq-o5nZQ4

Der zweite Wirkungsweg verläuft Uchino (2006) zufolge über *psychologische Prozesse*, die mit sozialer Integration und Unterstützung verbunden sind, nämlich Bewertungen, Emotionen beziehungsweise Gefühlszustände und Kontrollüberzeugungen. Ein großes soziales Netzwerk kann beispielsweise bei Personen günstigere Stressbewertungen hervorrufen (siehe auch Kurs 1, Kapitel 7 „*Stress und Stressbewältigung*"), da die externen Ressourcen als hoch eingeschätzt werden. Zudem kann konkrete Hilfe bei der Bewältigung von stresshaften Situationen die Kontrollüberzeugung stärken (Dukes Holland & Holahan, 2003; Thoits, 1986). Dies wiederum kann positive Effekte auf den emotionalen Zustand einer Person haben.

In beiden Wirkungswegen werden dem integrativen Modell zufolge physiologische beziehungsweise biologische Prozesse angestoßen, die wiederum einen Einfluss auf die Morbidität und Mortalität haben. Kardiovaskuläre, immunologische und neuroendokrine Prozesse vermitteln demnach den Zusammenhang zwischen Parametern sozialer Beziehungen und Mortalität. Es konnte beispielsweise gezeigt werden, dass soziale Unterstützung mit einer geringeren kardiovaskulären Stressreaktivität, einer besseren Immunfunktion und einem geringeren Anstieg von Cortisol während einer Stresssituation einhergeht (für eine Übersicht: Uchino, 2006).

3.4 Determinanten sozialer Integration und sozialer Unterstützung

Soziale Integration und soziale Unterstützung haben sich als wichtige Prädiktoren für die psychische und physische Gesundheit erwiesen. In welchem Ausmaß eine Person sozial integriert ist und wie viel soziale Unterstützung sie erhält, ist von verschiedenen Determinanten abhängig.

3.4.1 Determinanten sozialer Integration

Da soziale Integration über die Anzahl und Stabilität der sozialen Kontakte einer Person definiert ist, ist zu vermuten, dass die Determinanten sozialer Integration in der Person selbst, nämlich in Form von Eigenschaften, Verhaltensweisen, Einstellungen und Fähigkeiten, aber auch in der Interaktion mit Merkmalen anderer, wie z. B. der Ähnlichkeit, zu suchen sind.

Am Beispiel des Partnerschaftsstatus[3], einem wichtigen Indikator sozialer Integration, sollen im Folgenden mögliche Determinanten und deren Zusammenspiel illustriert werden. In verschiedenen Modellen zur partnerschaftlichen Beziehungsstabilität wird davon ausgegangen, dass sich die Wahrscheinlichkeit einer Trennung erhöht, wenn eine/einer oder beide Partner:innen unzufrieden mit ihrer Beziehung sind (Bodenmann, 1995; Karney & Bradbury, 1995; siehe auch Kurs 3, Kapitel 4 „*Gesundheitliche Beeinträchtigung und Partnerschaft*"). Die Partnerschaftszufriedenheit wiederum wird von verschiedenen sich gegenseitig beeinflussenden Faktoren beeinflusst. Im *Vulnerability-Stress-Adaptation-Model of Marriage* (VSA-Modell) von Karney und Bradbury (1995) sind dies neben *stresshaften Umständen* (wie kritische Lebensereignisse oder normative Übergänge) zum einen *stabile Charakteristika einer Person* (wie Persönlichkeitseigenschaften oder die Herkunftsfamilie) und zum anderen *adaptive Prozesse*, die Partner:innen während Interaktionen zeigen (wie Konfliktlöseverhalten oder der Emotionsausdruck). Im VSA-Modell wird davon ausgegangen, dass die stabilen Charakteristika einer Person den Ausgangspunkt bilden und einen Einfluss auf die adaptiven Prozesse in Interaktionen haben (Pfad A in Abbildung 3.5). Diese wiederum stehen in Wechselwirkung mit

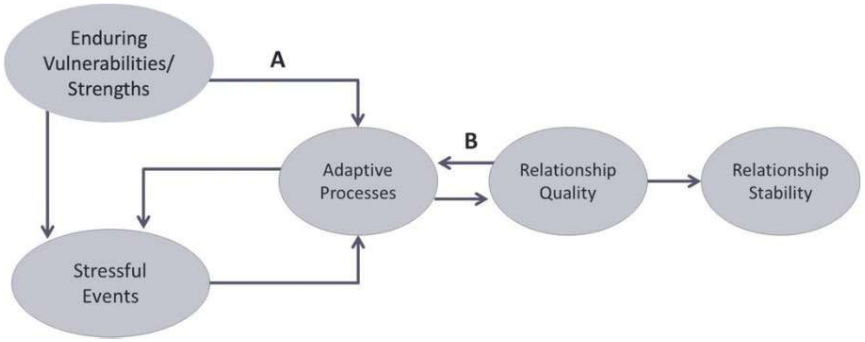
[3] Da der Begriff *Partner*schaft lang etabliert ist, wird in diesem Kapitel darauf verzichtet, genderkonforme, aber ungebräuchliche Begriffe zu verwenden.

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

der Beziehungszufriedenheit (Pfad B in Abbildung 3.5), welche wiederum die Beziehungsstabilität beeinflusst.

Abbildung 3.5

Vulnerability-Stress-Adaptation-Model of Marriage. Aus Karney und Bradbury, 1995, S. 23



Stabile Charakteristika und Erlebens- und Verhaltensweisen in Interaktionen

In zahlreichen Studien wurde untersucht, welche stabilen Charakteristika und Erlebens- und Verhaltensweisen einen Einfluss auf die Beziehungszufriedenheit und -stabilität von Paaren haben.

In Bezug auf die Big Five-Persönlichkeitseigenschaften wurden für Neurotizismus die stärksten Effekte auf Beziehungsvariablen gefunden. Beispielsweise gehen bei Singles hohe Neurotizismus-Werte mit einer höheren Wahrscheinlichkeit einher, eine Paarbeziehung einzugehen (Neyer & Lehnart, 2007). Bei einer bereits bestehenden Paarbeziehung ist eine hohe Ausprägung in Neurotizismus jedoch mit einer geringeren Beziehungszufriedenheit und -stabilität verbunden (Karney & Bradbury, 1995). In verschiedenen Studien wurden sowohl Akteur- als auch Partnereffekte[4] gefunden. Dies bedeutet, dass eine hohe Neurotizismus-Ausprägung nicht nur die eigene Beziehungszufriedenheit negativ beeinflusst, sondern auch die der Partner:innen. Als Mediatoren dieses Zusammenhanges werden ein negatives Interaktions- und Kommunikationsverhalten diskutiert (Caughlin et al., 2000; Donnellan et al., 2007).

Eine weitere Persönlichkeitseigenschaft, die häufig im Zusammenhang mit sozialen Beziehungen untersucht wurde, ist der dispositionale Optimismus. Es hat sich gezeigt, dass sowohl Optimist:innen selbst als auch deren Partner:innen zufriedener mit ihrer Beziehung sind und dass Optimismus (allerdings nur bei Männern) einen positiven Effekt auf die Partnerschaftsstabilität hat. Vermittelt werden diese Effekte durch kooperatives Problemlöseverhalten, konstruktive Problemdiskussionen, bessere Problemlösung sowie wahrgenommene soziale Unterstützung (z. B. Assad et al., 2007; Srivastava et al., 2006).

Als letzte personengebundene Determinante von Beziehungszufriedenheit und -stabilität soll der Bindungsstil vorgestellt werden. Der Bindungsstil entwickelt sich basierend auf Bindungserfahrungen im Kindesalter und es wird davon ausgegangen, dass Kinder ihre Erfahrungen mit ihrer Hauptbindungsperson zu Modellen verdichten, die ein Leben lang relativ stabil bleiben (Bowlby, 1995). Dadurch können Störungen in der kindlichen Bindungsbeziehung auch Auswirkungen auf Partnerbeziehungen im Erwachsenenalter haben. In einer Meta-Analyse über 73 empirische Studien zeigte sich, dass sich die ängstliche und die vermeidende Bindung unterschiedlich auf die Beziehungszufriedenheit und -qualität auswirken(Li & Chan, 2012). In Studien mit einem dyadischen Design wurden sowohl Akteur- als auch Partnereffekte gefunden (vgl. Feeney, 2008). Die gefundenen Zusammenhänge kommen unter anderem dadurch zustande,

[4] Akteur-/Partnereffekte: Die Begriffe ergeben sich aus der Übersetzung und beziehen sich auf alle Geschlechter.

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

dass sicher gebundene Personen eher konstruktive Konfliktlösestile und einen sozial verträglicheren Emotionsausdruck gebrauchen (Guerrero et al., 2009; Sierau & Herzberg, 2012).

Ähnlichkeit

Neben der Suche nach Merkmalen einzelner Personen als Einflussfaktoren auf die Qualität von Partnerbeziehungen, wird der Frage nachgegangen, inwieweit die Interaktion von Merkmalen der beiden Partner:innen (z. B. in Form von Ähnlichkeit) einen Einfluss auf die Beziehung hat. Etwas vereinfacht ausgedrückt, läuft es oftmals darauf hinaus, zu klären, welcher der bekannten Aussprüche zutrifft: „Gleich und Gleich gesellt sich gern" oder „Gegensätze ziehen sich an".

Empirische Studien liefern vor allem Evidenz für den ersten der beiden Aussprüche. Es wurde gefunden, dass die tatsächliche, aber auch die wahrgenommene Ähnlichkeit einen positiven Einfluss auf sowohl die anfängliche gegenseitige Anziehung als auch die Qualität und Stabilität der Beziehung hat. So zeigte sich beispielsweise, dass eine stärkere Ähnlichkeit der Einstellungen und Werte, der Persönlichkeitsprofile (z. B. hinsichtlich der Big Five-Eigenschaften und des Bindungsstils) sowie im Erleben von positiven und negativen Emotionen mit einer höheren Beziehungszufriedenheit und einer längeren Beziehungsdauer einhergehen (Karney & Bradbury, 1995; Luo & Klohnen, 2005). Gonzaga et al. (2007) fanden zudem, dass der positive Effekt der Ähnlichkeit der Persönlichkeit auf die Beziehungszufriedenheit dadurch vermittelt wird, dass die Partner:innen in spezifischen Situationen ähnliche Emotionen erleben.

3.4.2 Determinanten sozialer Unterstützungsprozesse

Unter welchen Bedingungen und in welchem Maße Unterstützungsprozesse stattfinden, hängt von einer Reihe verschiedener Variablen ab. In der Literatur werden vier teilweise überlappende und sich gegenseitig bedingende Faktorengruppen diskutiert, die den Erhalt und die Bereitstellung sozialer Unterstützung determinieren (für einen Überblick: Dunkel-Schetter & Skokan, 1990).

Charakteristika des Stressors

Verschiedene objektive Merkmale von Stressoren, wie Intensität oder Dauer, sowie subjektive Situationseinschätzungen sowohl des Empfängers als auch des Gebers können soziale Unterstützungsprozesse beeinflussen. Beispielsweise werden in Situationen, die als hochgradig stresshaft bewertet werden, mehr Unterstützungsleistungen erbracht als in wenig stresshaften Situationen (Dunkel-Schetter et al., 1987). Weiterhin rufen mehrdeutige Stressoren weniger soziale Unterstützung hervor als Stressoren, die einen eindeutigen Schaden oder Verlust beinhalten. Wenn sich Personen also nicht sicher sind, ob in einer Situation wirklich eine Bedrohung oder ein Schaden vorliegt, sind sie weniger geneigt, soziale Unterstützung zur Verfügung zu stellen.

Charakteristika des Unterstützungsempfängers

Auf der Seite des Empfängers haben sich drei Faktoren als bedeutsam im Hinblick auf den Erhalt beziehungsweise die Bereitstellung sozialer Unterstützung erwiesen, nämlich die Höhe der Belastung, das Bewältigungsverhalten sowie die personalen Ressourcen.

In verschiedenen Studien hat sich gezeigt, dass das subjektive Stresslevel und das Ausmaß negativer Emotionen sowohl einen positiven als auch einen negativen Einfluss auf den Erhalt sozialer Unterstützung haben können. Zum einen wurde gefunden, dass aus Sicht der Empfänger mit steigender Stressbelastung der Erhalt sozialer Unterstützung zunimmt (Miller et al., 1998). Zum anderen deuten empirische Befunde darauf hin, dass ein zu hohes Ausmaß emotionaler

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Belastung und speziell der Ausdruck depressiver Stimmung die Bereitschaft zum Geben sozialer Unterstützung verringert und negative soziale Reaktionen bei Unterstützungsgebern hervorruft (Yee & Greenberg, 1998). Demnach scheint die günstigste Voraussetzung für soziale Unterstützungsleistungen ein mittleres Maß an emotionaler Belastung des Empfängers zu sein, da einerseits der Bedarf an Unterstützung signalisiert wird und andererseits der Unterstützungsgeber nicht zu stark beansprucht wird (Silver et al., 1990).

Des Weiteren beeinflusst das gezeigte Bewältigungsverhalten (siehe auch Kurs 1, Kapitel 7 „Stress und Stressbewältigung") des Empfängers die Menge an sozialer Unterstützung, die in einer stresshaften Situation zur Verfügung gestellt wird. Dabei wirkt sich aktives und situationsangemessenes Bewältigungsverhalten seitens des Empfängers insgesamt positiv auf die Unterstützungsbereitschaft des potenziellen Gebers aus (Schwarzer & Weiner, 1991). Insbesondere eine annähernde Bewältigung, wie aktives Problemlösen oder positive Uminterpretation, begünstigt den Erhalt sozialer Unterstützung, während eine maladaptive Bewältigung zum Beispiel in Form von Rumination, Vermeidung oder Fokussierung auf negative Emotionen den Erhalt von und die Bereitschaft zu sozialer Unterstützung senkt. Zudem ist die aktive Suche nach sozialer Unterstützung als Bewältigungsstrategie mit dem Erhalt von mehr Unterstützung assoziiert (Dunkel-Schetter et al., 1987; Flynn & Lake, 2008; Winkeler et al., 2006).

Letztlich stehen die personalen Ressourcen auf Seiten des Empfängers mit dem Erhalt sozialer Unterstützung in einem signifikant positiven Zusammenhang. Die Ergebnisse verschiedener Studien legen nahe, dass personale Ressourcen, wie Optimismus, Selbstwirksamkeitserwartungen und ein hohes Selbstwertgefühl, mit mehr tatsächlicher sozialer Unterstützung einhergehen (z. B. Vollmann et al., 2011).

Charakteristika des Unterstützungsgebers

Ob und in welchem Umfang soziale Unterstützungsleistungen zur Verfügung gestellt werden, wird weiterhin von verschiedenen Faktoren auf Seiten des Unterstützungsgebers beeinflusst.

Zum Ersten spielen Kausalattributionen über die Kontrollierbarkeit des Situationseintritts eine wichtige Rolle, da sie bestimmte Emotionen hervorrufen, die ihrerseits wiederum auf das Unterstützungsverhalten wirken. Studienergebnisse deuten darauf hin, dass unkontrollierbare Stressursachen vorrangig Mitleid und Sympathie auslösen und damit die Unterstützungsbereitschaft begünstigen, während kontrollierbare Stressursachen hauptsächlich Ärger entstehen lassen und somit die Bereitschaft zu sozialer Unterstützung verringern (Schwarzer & Weiner, 1991).

Zum Zweiten haben die Emotionen, die beim potenziellen Unterstützungsgeber durch die Interaktion mit der unterstützungsbedürftigen Person ausgelöst werden, einen bedeutsamen Einfluss auf die Bereitschaft, soziale Unterstützung zu gewähren (Wortman & Lehman, 1985). Empathie und Mitgefühl beispielsweise fördern die altruistische Motivation, soziale Unterstützung zu leisten (Trobst, 2000). Hingegen sind negative affektive Zustände, die durch den Kontakt mit einer belasteten Person ausgelöst wurden, mit einer geringeren Bereitschaft zu sozialer Unterstützung assoziiert: Der Ausdruck von emotionaler Belastung und negativer Stimmung seitens des Unterstützungsempfängers kann bei potenziellen Unterstützungsgebern negative Gefühle, wie Depression, Ängstlichkeit oder Feindseligkeit, hervorrufen und soziale Ablehnung nach sich ziehen(Silver et al., 1990). Zudem kann die Interaktion mit Opfern kritischer Lebensereignisse auf potenzielle Unterstützungsgeber bedrohlich wirken, da die eigene Vulnerabilität stärker in den Fokus der Aufmerksamkeit rückt und der Glaube an eine gerechte Welt erschüttert wird (vgl. Wortman & Lehman, 1985).

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Zum Dritten können eigene Erfahrungen mit stresshaften Situationen oder kritischen Lebensereignissen die Bereitschaft zu sozialer Unterstützung beeinflussen (vgl. Dunkel-Schetter & Skokan, 1990). Es wird angenommen, dass sich eigene Erfahrungen als Unterstützungsempfänger aber auch als Unterstützungsgeber positiv auf die Unterstützungsbereitschaft auswirken, da sie einerseits die empathische Motivation erhöhen und andererseits das Vertrauen in die eigenen Unterstützungskompetenzen fördern (Antoniw et al., 2007). Weiterhin werden durch eigene Erfahrungen Gefühle der Hilflosigkeit und der Unsicherheit hinsichtlich effektiver Unterstützungsangebote verringert.

Charakteristika der Beziehung

Unterstützungsprozesse werden weiterhin durch verschiedene Merkmale der Beziehung zwischen dem Unterstützungsempfänger und dem Unterstützungsgeber beeinflusst (vgl. Gottlieb & Wagner, 1991).

Eine hohe Intimität beziehungsweise Vertrautheit in der Beziehung sowie eine hohe Zufriedenheit mit der Beziehung stehen beispielsweise in einem positiven Zusammenhang mit dem Austausch sozialer Unterstützung (Dunkel-Schetter et al., 1992).

Weiterhin haben bisherige Unterstützungsprozesse innerhalb der Beziehung einen Einfluss auf die Bereitschaft, zukünftig soziale Unterstützung bereitzustellen. Früher erfahrene Zurückweisung der angebotenen Hilfe oder wahrgenommene Ineffektivität der eigenen Unterstützungsangebote führen zu einer Verringerung der Unterstützungsbereitschaft und zu negativen Reaktionen gegenüber der Person, die die Hilfe zurückgewiesen hat (Cheuk & Rosen, 1992). Hingegen ist entsprechend der Austauschtheorie der frühere Erhalt von sozialer Unterstützung ein guter Prädiktor für eigene Unterstützungsleistungen, da eine Reziprozität hinsichtlich unterstützender Interaktionen angestrebt wird (Piferi & Lawler, 2006).

Literaturverzeichnis

Antoniw, K., Borghardt, A. & Weber, H. (2007). Des Guten zuviel: Der Einfluss von Bewältigungsverhalten auf die Bereitschaft zu sozialer Unterstützung. *Zeitschrift für Gesundheitspsychologie*, *15*(4), 158–167. https://doi.org/10.1026/0943-8149.15.4.158

Assad, K. K., Donnellan, M. B. & Conger, R. D. (2007). Optimism: An enduring resource for romantic relationships. *Journal of Personality and Social Psychology*, *93*(2), 285–297. https://doi.org/10.1037/0022-3514.93.2.285

Bodenmann, G. (1995). *Bewältigung von Stress in Partnerschaften: Der Einfluss von Belastungen auf die Qualität von Paarbeziehungen*. Huber.

Bolger, N., Zuckerman, A. & Kessler, R. C. (2000). Invisible support and adjustment to stress. *Journal of Personality and Social Psychology*, *79*(6), 953–961. https://doi.org/10.1037//0022-3514.79.6.953

Bowlby, J. (1995). Bindung: Historische Wurzeln, theoretische Konzepte und klinische Relevanz. In G. Spangler & P. Zimmermann (Hrsg.), *Die Bindungstheorie: Grundlagen, Forschung und Anwendungen* (S. 17–26). Klett-Cotta.

Caughlin, J. P., Huston, T. L. & Houts, R. M. (2000). How does personality matter in marriage? An examination of trait anxiety, interpersonal negativity, and marital satisfaction. *Journal of Personality and Social Psychology*, *78*(2), 326–336. https://doi.org/10.1037//0022-3514.78.2.326

Cheuk, W. H. & Rosen, S. (1992). Helper reactions: When help is rejected by friends or strangers. *Journal of Social Behavior and Personality*, *7*(3), 445–458.

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440